Treatment Advised

TAB. LZLNZD (600) TWICE A DAY
0——0 X 5 DAYS

TAB. RYL-20 1 TAB TWICE A DAY
0——0 X 5 DAYS

TAB. ACE-CP 1 TAB TWICE A DAY
0——0 X 5 DAYS

Review After 5 Days | IOS

Obtain Urgent Care if you have

- Excessive pain
- Swelling
- Bleeding

[redacted]

In Case of Emergency Please Contact :

[redacted]

[redacted]

Mob. : [redacted]

DISCHARGE-TICKET

Name of Patient [redacted]

Age 61 Y Sex M

Address [redacted]

UHID No : 145409

IPD No. IP2505172

Ward MGW Bed No. 10

Date of Admission 18/02/26

Date of Operation 21/02/26

Date of Discharge 25/02/26

Consultant [redacted]

Final Diagnosis OSTEOARTHRITIS RIGHT KNEE

ADMISSION FORM

REG NO	145409	IPD NO.	IP2505172
PT NAME	[redacted]	AGE/SEX	61 Y / M
RELATION	[redacted]	CATEGORY	PMJAY ODISHA
LOCATION	4TH FLOOR	WARD/ROOM NO	GENERAL WARD
BED NO	16	D.O.A. & TIME	18-02-2026 & 8:11PM
MOBILE NO	[redacted]	D.O.D. & TIME	
MLC	YES /NO	ADMISSION DATE	18-02-2026 &8:11PM
MARITAL STATUS			
AADHAAR NO			
ADDRESS	[redacted]		
CONSULTANT			

Provisional Diagnosis
ICD Code

OSTEOARTHRITIS RIGHT KNEE

Final Diagnosis
ICD Code

OSTEOARTHRITIS RIGHT KNEE

Procedure

TKR (R) Side

Result

Cured/Relieved/L.A.M.A./Refer/DOR/Expired

Date Of Death
Signature of Director / [redacted]

[redacted]

AUTHORISATION FOR TREATMENT AND OPERATION

I hearby authorise the Medical, Nursing and Para Medical Staff of the Hospital to investigate, treat and administer such drugs as may be necessary in the diagnosis and treatment of [redacted]
Who is my [redacted] [Relation]
I also acknowledge having been informed of the General Rules and Regulations of the Hospital
All Cash, jewellery and Valuable belongings of the patient have been removed to place of safety. I absolve the Hospital of any [redacted] rd to any loss.

[redacted]

Signature/Name of Admitting Clerk
[redacted]

[redacted]

Signature C/o
[redacted]
FATHER

[redacted]

CASE SUMMARY
(HOSPITAL COPY)

Admission Note

Name & Address : [redacted]

ADD - [redacted]

GDSA

Phone No. / Mobile :

Age : 61y Sex : MALE Wt.

Regd. No. / Date : 5043 Bed No. : M [illegible] (2)

D.O. Admission : 18/02/26 At. 8:11 AM

D.O. Operation / Delivery : 21/02/26

D.O. Discharge : 23/02/26

Ref. by Dr.

Consultant Dr. [redacted]

Provisional Diagnosis :

RIGHT KNEE O.A.

Admission Status :

GCS - 15/15

BP - 130/90 mmHg

Pulse - 88/min

SpO2 - 98%

Temp - (N)

Investigation :

Hb% - 11.8 gm

Blood group - O+ve

HIV, HCV, HBsAg - Neg

Management :

O.P. Intervention

Discharge Note

Final Diagnosis :

O OSTEOARTHRITIS RIGHT KNEE

Discharge Advice :

SOS discharge advice

Cause of Discharge : Improved/Cured/On Request Against Medical Advice/Death

Discharge Status : Stable

डॉ. आर.एल. हॉस्पिटल
रायगढ़ (छ.ग.)

आय. डी. ॲडमिशन कन्सेंट

मरीज/रूग्ण के अस्पताल/रूग्णालय प्रवेश का अधिकार अस्पताल/रूग्णालय के प्रबंधक के पास सुरक्षित है ।

अनुमति/मान्यता-पत्र

1) रूग्ण की बिमारी एवं स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में मुझे/हमे डॉक्टर ने (डॉक्टरों ने) पूर्ण रूप से जानकारी दी है ।

2) रूग्ण की जाँच-पड़ताल, उस पर किए जाने वाले औषधोपचार, उसके परिणामों/दुष्परिणामों से मुझे/हमें पूरी तरह से अवगत कराया गया है ।

3) यदि आवश्यकता निर्माण हो तो, अतिरिक्त सलाह/विचार विमर्श हेतु विशेषज्ञों से सलाह/मशवरा करने की सम्मती/अनुमती मैं/हम डॉक्टरों को देता हूँ ।/देते है । जिससे होने वाले अतिरिक्त खर्च की जिम्मेदारी मुझे/हमें मंजूर है ।

4) रूग्ण/मरीज को आवश्यकता पड़ने पर अतिदक्षता विभाग में (I.C.U. में) दाखिल करने तथा उसके अतिरिक्त खर्च के लिए मैं/हम सहमती देता हूँ/देते है । साथ-साथ मैं/हम परिणामों के उत्तरदायित्व को भी स्वीकार करता हूँ ।/करते है ।

5) आवश्यकतानुसार मरीज की सभी प्रकार की जाँच-पड़ताल/उपचार के लिए मेरी/हमारी सहमती है । संभाव्य दुष्परिणामों की जानकारी मैं/हम, डॉक्टर से/डॉक्टरों से, समय-समय पर प्राप्त करूंगा/करेंगे ।

6) रूग्णालय में इस्तेमाल की जाने वाली सभी दवाईयाँ/सलाईन की बोतले/सलाईन उपकरणों आदि का उत्पादन रूग्णालय में नहीं होता तथा अस्पताल में/रूग्णालय में इस्तेमाल की जाने वाली सभी दवाईयां/उपकरण प्रमाणित संस्थाओं से खरीदी जाती है । इस की मुझे/हमे जानकारी है ।

7) मरीज के स्वास्थ की प्रगती के बारे में मैं/हम डॉक्टरों से समय समय पर जानकारी लेता रहूँगा/लेते रहेंगे ।

8) रूग्ण द्वारा या उसके रिश्तेदारों द्वारा यदि रूग्णालय की वस्तुओं की या उपकरणों की टूट-फूट/नुकसान-हानि होता है, तो उसके लिए मैं/हम जिम्मेदार रहूँगा/रहेंगे तथा उसका भुगतान मैं करूंगा/हम करेंगे ।

9) रूग्णालय में उपलब्ध/अनुपलब्ध सुविधाओं की पूरी जानकारी मुझे है ।/हमें है ।

10) ऑपरेशन के दौरान मेरे/रूग्ण के शरीर से निकाले गए पदार्थ, स्नायु/अवयवों की जाँच पड़ताल एवं तदुपरांत उसका निपटान रूग्णालय के नित्यनियमों के अनुसार करने के लिए मैं/हम अनुमती देता हूँ ।/देते है ।

11) वैद्यकीय ज्ञानवृद्धी हेतु औषधोपचार/ऑपरेशन/उपचार प्रक्रिया के दौरान मेरे/रूग्ण के लिए गए छायाचित्र (Photographs-Transparenices) दृक-श्राव्य फिते (Audio-Visual Tapes) का प्रदर्शन या प्रकाशन के लिये मैं/हम सहमती देता हूँ/ देते है, बशर्ते कि ऐसा करते समय मेरी/रूग्ण की पहचान नहीं दी जाएगी ।

मैं/हम ने उपरोक्त अनुमति/मान्यता-पत्र पढ़ लिया है, मैंने/हमने समझ लिया है।/मैं/हम उसका पालन करूंगा /करेंगे ।
आपसे मैं/हम विनती करता हूँ/करते है कि कृपया मुझे/मरीज को इस रूग्णालय में प्रवेश देने की कृपा करें ।

मरीज का नाम : राम बाग [redacted]

अस्पताल/रूग्णालय का नाम : डॉ. आर. एल. हॉस्पिटल

नाम : अनाम

मरीज से रिश्ता : भाई

हस्ताक्षर/या बाये हाथ के अंगुठे का निशान

दिनांक : 18./02./26.. समय : 8:11 PM

उपरोक्त अनुमति/मान्यता-पत्र मुझे मेरी मातृभाषा में समझाया गया है,

मैंने उसे समझ लिया है । मैं उसे बंधन कारक मानता हूँ ।

गवाह का नाम : कुंजबिहारी सुन्दरगढ़, उड़िसा	नाम : [redacted]
पता :	बाये हाथ का अंगुठा :

:: परिशिष्ट – क ::

(बिल/अन्य व्यय के खर्च के लिए अनुमति-पत्र)

मुझे हमें/संभाव्य अनुमानित खर्च की जानकारी दे दी गई है । मैं/हम औषधोपचार/उपचार प्रक्रिया/जाँच पड़ताल/परीक्षण आदि के लिए होने वाले प्रतिदिन के खर्च के व्यय का भुगतान करने के लिए सहमत हूँ ।/है ।

नाम : [redacted]	मरीज से रिश्ता : भाई	हस्ताक्षर : [redacted]
पता : [redacted]	दिनांक : 18./02./26....	
	समय : 8:11 PM	बाये हाथ का अंगुठा :

डॉ. आर.एल. हॉस्पिटल
रायगढ़ (छ.ग.)

सहमति - पत्र

पेशंट (याने मरीज/रुग्ण/रोगी) की जानकारी	रिश्तेदार की जानकारी
नाम : [redacted]	नाम : [redacted]
लिंग : ☑ पुरुष ☐ स्त्री ● उम्र 61 साल	लिंग : ☑ पुरुष ☐ स्त्री ● उम्र 54 साल
रजि. नं. 2505172	पता : [redacted]
निदान : Osteoarthritis (R) knee	
शस्त्रक्रिया का नाम : (R) TKR	पेशंट से नाता : भाई

मैं ---------- नीचे हस्ताक्षर करने वाला

☐ खुदपर / ☐ उपरोल्लेखित पेशंट उपरोक्त शल्य क्रिया/उपचार/जाँच/पड़ताल/दवाईयाँ/उपचार पद्धति के लिए मेरी सहमति प्रदान करता हूँ।

1) इस औषधोपचार / शल्यक्रिया (ऑपरेशन) जाँच-पड़ताल/अनेस्थेशिया उपचार पद्धति की आवश्यकता, न करने से होने वाले परिणाम, शल्यक्रिया के अतिरिक्त अन्य उपचारों के खतरे और समस्याओं आदि के बारे में डॉक्टर डॉ. प्रशांत अग्रवाल ने मुझे पूर्णरूप से समझा दिया है।

2) मुझे स्पष्ट रुपसे यह जानकारी दे दी गई है कि, कोई भी औषधोपचार/शल्यक्रिया (ऑपरेशन)/जाँच-पड़ताल/अनेस्थेशिया, उपचार पद्धति पूर्णत: सुरक्षित नही होती तथा उनके प्रयोग से सामान्यत: स्वस्थ/तंदुरुस्त व्यक्ति के जीवित को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है।

3) इस औषधोपचार/शल्यक्रिया (ऑपरेशन)/जाँच-पड़ताल/अनेस्थेशिया उपचार पद्धति के दौरान अत्याधिक स्त्रावाव, संसर्गजन्यता, हृदय की गति रुकना या फेफड़ों में रक्त गुठली का अटक जाना, इस तरह के या अन्य खतरें भी अकल्पित/आकस्मिक रुप से निर्माण हो सकते है, इन संभावनाओं से मुझे डॉक्टरों ने अवगत कराया है।

4) दवा देते समय/जाँच-पड़ताल के वक्त या ऑपरेशन/उपचार पद्धति के दौरान डॉक्टरों को स्थिति के अनुरुप ऑपरेशन/अनेस्थेशिया में परिवर्तन करना यदि आवश्यक हो गया तो, या शरीर के किसी भी अवयव को निकालना हो, तो इन परिवर्तनों के लिए मैं सहमति देता हूँ। इन संभावनाओं की जानकारी मुझे दे दी गई है।

5) औषधोपचार/शल्यक्रिया (ऑपरेशन)/जाँच-पड़ताल/अनेस्थेशिया या उपचार पद्धति के दौरान/पश्चात अपेक्षित लाभ के बजाय हानि भी हो सकती है, या खतरा / अन्य तकलिफे भी पैदा हो सकती है। उदाहरणार्थ ---------- ऐसी स्थिति में उन्हें दूर करने के लिए

शल्यक्रिया तज्ञ/डॉक्टर ---------- [redacted] ----------

अनेस्थेशिया तज्ञ/डॉक्टर ---------- [redacted] ----------

आवश्यक सावधानी बरतेंगे या अन्य तज्ञ डॉक्टरों की सहायता/विमर्श लेंगे। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। और इसे मेरी सहमति भी है।

☐ उपरोक्त दस्तावेज मैंने पढ़ा है। ☐ मुझे पढ़कर समझा दिया गया [redacted]

मैं इस के लिए सब जानकारी रखते हुए स्वेच्छा से सहमति प्रदान करता

गवाह	गवाह	मरीज / रिश्तेदार
हस्ताक्षर [redacted]	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर / अंगूठा का निशान
नाम [redacted]	नाम	
पता [redacted]	पता	ता. 18/02/26
उम्र साल ता. 18/02/26	उम्र 54 साल ता. 18/02/26	समय : 8:11 PM

[redacted]

[redacted]

Pre Op Order

Name of Patient : [redacted]

A/S : 61Y/M

Room No. : Mwd

Diagnosis : Osteoarthritis (R) knee

Operation Name : (R) TKR

Date : 21/2/26

- Take written consent
- Shave and prepare part
- Xylocaine Sensitivity test
- Inj. i/m T. T. 0.5 mL stat

done

- Enema at .....
- Nil orally since 11am
- Inj. i/v Tazomex 4.5gm ½ hr. before O. T.
- Inj. i/v Acilox 1 AP ½ hr. before O. T.
- Catheterization Yes / No

BP-130/80 mmHg

PR- 82/m

Tem - (N)

SpO2 - 96 %

[redacted]

I/c Medical Officer

O .T. Notes

Patient Name - [redacted]

Surgeon Name - [redacted]

Assistant - [redacted]

Nurse - [redacted]

Anaesthesist - [redacted]

Type of Anaesthesia - spinal

Operation Name - TKR (R) side

Operation Date & Time - 21/2/26

Tourniquet Time -

Implant Used -

— Spinal anesthesia used and patient was laid supine on OT table

— Subvastus approach to knee used and steps followed accordingly

— Total knee replacement (R) side done

— wound closed in layers and Steri strips applied

— Stable vitals patient shifted out of OT

[redacted]

Surgeon

[redacted]

Anesthetic Assessment Chart

Name of Patient : [redacted]

IPD No. : 9P25051792

Date of Admission : 12/02/2026

Assessment Items	Condition	Grade
Activity, able to move Voluntarily or on command	4 extremities	2
	2 extremities	1
	No	0
Breathing	Able to breathe deeply & cough freely	2
	Dyspnea, shallow or limited breathing	1
	Apnea	0
Consciousness	Fully awake	2
	Arousable on calling	1
	Unresponsive	0
Circulation (BP)	± 20% of preanesthesia level	2
	± 50% of preanesthesia level	0
SPO2	Maintains SpO_2 > 92% in ambient air	2
	Maintains SpO_2 > 90% with O2	1
	Maintains SpO_2 < 90% with O2	0

9/10

[redacted]

Signature ..... **Reg. No.** CMC3934/2012 **Time/Date** 12/02/26

[redacted]

PRE ANESTHETIC CHECK LIST

[redacted]

Name of the patient: [redacted]

IP No.: 5172

Weight of the pt:

Date of Admission: 28/01/26

Caste of the pt: Hindu

Identification Marks:

Allergies: no

Informed about surgery? yes

Time of last food intake: 8 hrs

Taken bath? no

Type of food taken last: roti

Consent Form Signed? yes

Approx. duration of surgery: 1½ hrs

Type of anasthesia: Spinal

Alcoholism?

Dentures if any, removed? yes

Loose teeth? / no

Jewels if any, removed? yes

Smoker?

Serious illness in the pest: no

Previous operations? no

Problems with anasthesia? no

Drug Allery: no

BP Patient? no

Heart problem?

Joint swelling in past? no

Fainted?

Bleed excessively? no

Anemia?

Cold Now? no

Asthma / wheeze?

Nose block / sneeze: no

Fits? / no

Drugs Taken so far:

Recent injury?

Breathlessness?

Jaundice in past?

Kindey problem?

Blood Glucose: 120mg/dl

BP: 130/90mmHg

PR: 72/min

Venflow working? yes

TT inj: yes

Xylo test Dose? yes

Hb: 11.2g

Fundus examn:

BT:

CT: -

Urine passed? catheterization

Grp/Rh: O+ve

ECG: done

Teeth: yes

Grp x matched?

Checked? yes

Blood reserved? -

CXR1: yes

Temp? N

PCV:

Urine Acetone :

u/s abd: stoff

Platelet Count: 244

HBsAG: -ve

HIV: -ve

CVS: NAD

Nose: yes

Throath: yes

Teeth: yes

RS: NAD

Abd: stoff

CNS: NAD

Joints: movable

LMP: -

Skin infection? no

Beta HCG urine: no

Echo: -

TMT: no

Advance? no

Plan of Anesthesia ..... Spinal .....

Signature ..... [redacted] ..... **Reg. No.** ..... CMC3931/2018 ..... **Time /Date** 21/2/26

[redacted]

[redacted]

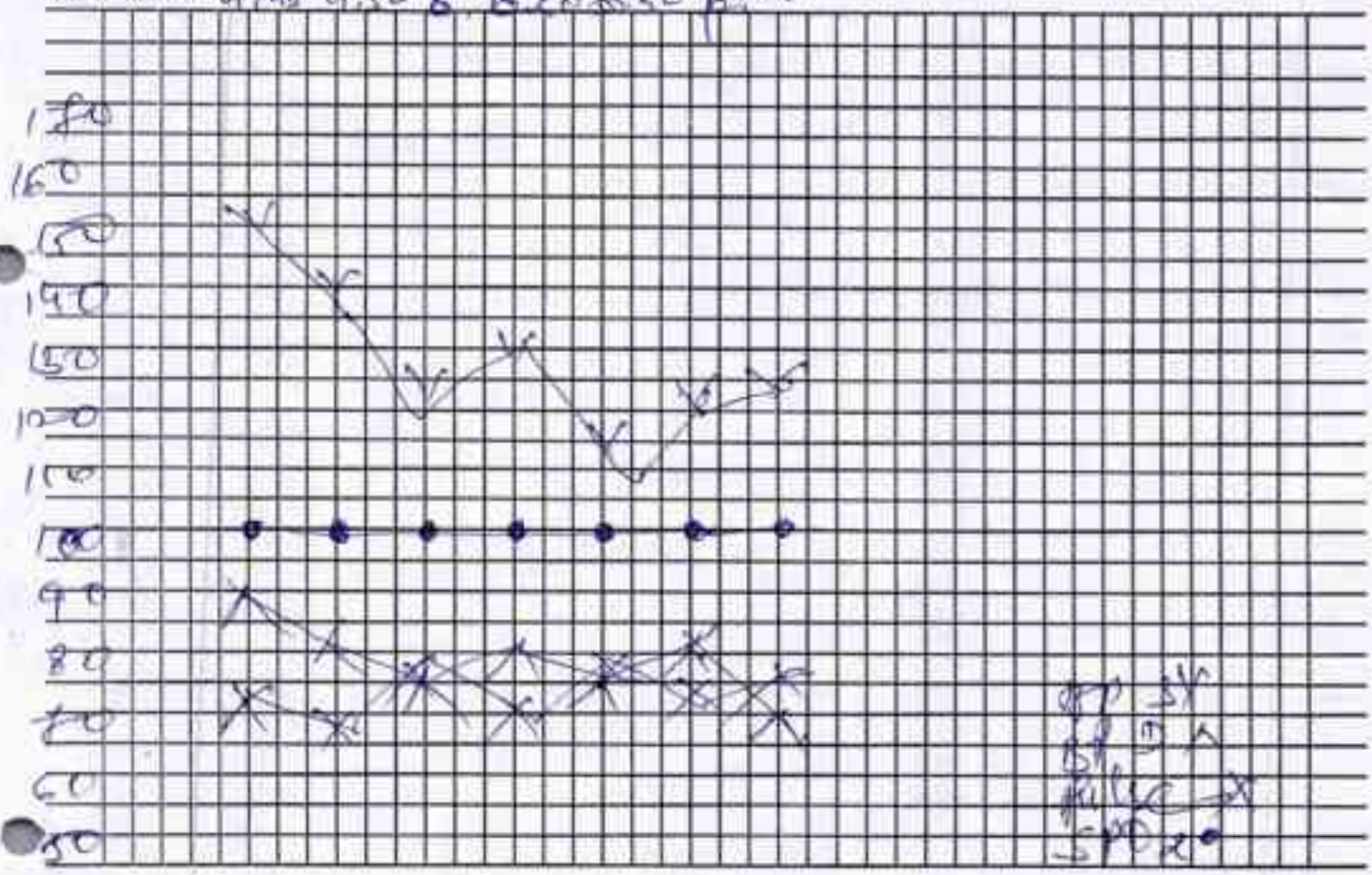
ANAESTHESIA RECORD

Anesthesia and Drug Given In Theater Introduction : Maintenance : Reversal :

Anesthesiologist : [redacted] Surgeon : [redacted]

Surgery Time Start : 6AM Finish : 7:30PM Anesthesia Time Start : 5:45 Finish : 7:30PM

Ventilation SV. 4:45 4:50 5 5:20 5:50 7:00



Full Operative Observation :

[redacted]

An[redacted] Signature [redacted] Reg. No: CMC3734/2018 Time/Date 21/2/26

Post operative Instruction :

- O2
- ICCU Care
- Propped up/Head Low
- Analgesics

[redacted] 5:45AM

Name [redacted]

Reg. No. CMC3734/2018 Date/Time 21/2/26

[redacted]

Anesthesia Post - Operative Assessment

Date of Post-op assessment: 21/2/26

Vitals BP: 126/90 Resp: 18 Temp: N Deg C ☐ Axillary ☐ Oral ☐ Rectal ☐ Tympanic

Pulse: 77 ☐ Regular ☐ Irregular Other

Oxygenation O2 Sat 100 %

Pain /10 ☐ Minimal ☐ Poorly Controlled Other

Cardiovascular ☐ Stable Other

Resperatory ☐ Breathing Comfortably ☐ Tachypnea ☐ Stridor ☐ Mechanically Ventilated

Other

Mental Status Conscious Other / Unconscious

Nausea and Vomiting No Other

Hydration Good Other

Disposition (Use Only if in PACU) Conscious Other

Additional Comments

Name [redacted] Date 21/2/26

Signa[redacted]

Patient Name	[redacted]
Med. Record #	
Account #	
Date of Surgery	21/2/26

[redacted]

Anaesthesia Notes

Name of Patient [redacted] **A/S :-**

Operation Name **Date :-** 21/2/26

ASA I
MPGIT
PAC fit

[Case done ↓SAB]
- ↓AAP
- Level 4/5
- Position setting
- inj 1% lignocaine (0.5%) 2ml
- MAC O

Adv
- NBM for 6 hours
- foot end raised
- vital monitoring
- E/O charting
- maintain hydration

[redacted]

[redacted]

Checklist for Shifting from OT to Ward

Name of Patient [redacted] Age/Sex 6.1Y/M Ward/bed MW UHID IN 5409

Surgeon [redacted] Reg. No. CMC 4882/2012 Surgery Performed (R) TTCR

Anesthetist [redacted] Reg. No. CGMC 3934/2012 Anethesia SA

Surgery Started at 6 pm Finished at 7 pm

Shift Patient only

Fully conscious	Y/N ✓
Respiration rate between 16-20	Y/N Actual rate 16
Pulse rate between 60-100	Y/N Actual rate 76/min
Systolic Blood Pressure at least 100	Y/N BP 120/80 mm of Hg
Cyanosis	Present/Absent Absent
Shivering or Sweating	Present/Absent Absent
Patient is comfortable	Y/N ✓
Alarming soakage from wound	Y/N

If patient not fully conscious or is unable to maintain vitals unsupported or requires care in ICU, patient should be futher managed in ICU.

Or

In spite of these Surgeon and Anesthetist feel that patient can be managed in ward patient should be shifted to ward with instruction to RMO to provide extra care.

[redacted]

Sign of OT Sta[redacted]

Name

Date 21/2/26

[redacted]

Sign of Surgeon/Consultant

Name [redacted]

Reg. No. CMC 4882/2012 Date 21/02/26

[redacted]

[redacted]

Post OP Assessment Chart

Patient ID 2505172

Patient Name [redacted]

Surgery : (R) TICR

Surgeon : [redacted]

Anaesthetist : [redacted]

Date : 21/02/26

Received Time : 5:30 pm

Transfer Out Time : 7:30 pm

Aneasthisia : GA ☐ SA ☑ EA ☐ LA ☐

Condition on Arrival : Conscious ☑ Semi Conscious ☐ Unconscious ☐ Disoriented ☐

Sr No.	Time	Temp (F)	Pulse (n/min)	BP (mm Hg)	SpO_2 (%)	Resp. (n/min)	Pain Score	Remarks
1	6:30pm	98.6	56	120/70	99+	20+	0	
2	7pm	(N)	56	120/90	98+	18+	0	
3	8pm	(N)	62	120/80	100+	20+	0	
4	9pm	-	62	120/90	96+	18	0	
5	10pm	(N)	68	130/80	98+	16	0	

IV Fluid : On Flow RL 100

Blood : NO

Foleys Catheter : Yes ☑ No ☐

Drains : Yes ☑ No ☐

Next Point : OT

Urine Output : 100ml in bag

Drain Output : NIL

Recovery Notes : Pt N/B/M for [redacted]

Signature

POST OP - ORDER

Specific orders

pt NBM for 6hrs

Rx
IV - TAZOMAX 4.5gm (TMROW A DAY)
IV - ALTOC MAP (TMROW A DAY)
IV - AMICIN 500mg (TMROW A DAY)
IV - PCM 1000ml (TMROW A DAY)

~~IV~~ DST / RO
DNS

[redacted]

Designation:

Date: 21/12/26 Time:

Specific anesthetic orders

- NBM for 6hrs
- foot end Raised
- vital monitoring
- I/O charting
- maintain hydration

[redacted]

Designation:

Date: 21/12/26 Time:

Day Procedure Discharge Planning Please tick ✓

☐ Discharge Prescription	☐ Outpatients Appointment	☐ Medical Certificate	☐ Written Instructions

History

c/o - pain in Right knee joint x 12 yrs.
- difficulty in walking

NO past medical history of T2DM / HTN

Admission Status

GIE: Pain
CVS: S1S2 (+)
RIS: B/L clear
B.P.: 130/90
P/S: Cept (+)
Pulse: 86 b/m
CNS: conscious/oriented.

Investigation Done:

Hb - 11.8 gm
TLC - 5.03
B. Group - O+ve
S. CREAT. 1.1
RBS - 130
HIV
HCV
HBsAg
} Negative
ECG - ND

History

Date: 21/12/2026
Surgeon: Dr. Anant Singh
Anaesthetist: Dr. P.L. Patel
Operation: TKR (RT)

Treatment Given

INJ. TAZOMAC 4.5 gm THRICE A DAY
INJ. AMIKACIN 500 TWICE A DAY
INJ. ACELOC 1 (S) TWICE A DAY
INJ. PCM 1 gm IV THRICE A DAY.

Discharge Status

GIE Pain
- All vitals stable

Wound Condition

Dry (+)